

第4場_藥師轉介醫師轉介單草案

緊急事後避孕藥（ECP）試辦計畫 | 藥局→醫療院所 轉介單（草案） 整理：2026-07-18 · 用途：第 4 場會議（第 10 章 轉介判斷準則 / 轉介工具）提出討論 試辦藥品以 LNG（Levonorgestrel，左炔諾孕酮）為限；緊急避孕藥=Emergency Contraceptive Pill（ECP）。

設計依據（會議結論）：①轉介以標準化轉介單載明事由、藥師已詢問項目隨單附上、免重複問診（黃建霏秘書長）；②建立藥師↔醫師雙向聯絡管道與回覆（張文靜常務理事、現行藥事照護計畫紙本雙向轉介回覆單回覆率約 6—7 成）；③紅黃綠分流依第 10 章及《藥局供應 ECP 評估與轉介流程表》；④第 3 場已定系統自動產出轉介單、電子化為主、紙本備援。

一、設計說明（供專家討論，非表單本體）

- 兩種轉介性質（依流程表）：
 - 不供藥、直接轉介：藥師端未供藥，請醫師接手評估 / 處置。
 - 已先給藥、建議醫療轉介：藥師已先供 LNG（把握時效、預防懷孕優先），請醫師就臨床風險後續評估。
 - ⚠ 疑似急性子宮外孕現症：屬救命外科急症，逕送有婦產科之急診（非一般門診轉介）。
- 性暴力 / 性侵害個案另依 113 通報與社政一站式服務流程（另有通報作業）；如需醫療採證，一併轉介具社工之醫院。
- 電子化：正式運作由資訊系統依填答自動產出本單（欄位帶入線上評估與藥師現場評估資料）；紙本為備援。系統平台與回覆機制細節俟**第 5 場（8/12，第 12、13 章）**確認。

二、轉介單本體（欄位草案）

A. 轉介基本資訊

欄位	內容
轉介日期 / 時間	_____年____月____日 ____:____
轉介類型	☐ ● 不供藥、直接轉介 ☐ ● 已先給藥、建議醫療轉介 ☐ ⚠ 疑似急性外孕 →急診

欄位	內容
轉入院所別	☐ 婦產科診所 ☐ 婦產科（醫院） ☐ 具婦產科之急診 ☐ 具社工之醫院（性侵採證）
轉介單編號 / 購藥條碼	_____（系統碼，供院所調閱與雙向回覆對應）

B. 民眾基本資料

欄位	內容
姓名	_____
性別 / 年齡	____ / ____歲（未成年另依第 8 章年齡規定處理）
聯絡方式	_____
個資提供同意	☐ 已於線上簽署個人資料提供同意書

C. 轉介事由（可複選，對應流程表情境）

● 不供藥、直接轉介

- ☐ 疑似懷孕（驗孕陽性 / 不願驗孕）——請確認懷孕位置、排除子宮外孕
- ☐ 異常陰道出血——需排除子宮外孕 / 子宮內膜病變等（出血鑑別屬醫師專業）
- ☐ 逾 72 小時（LNG 為仿單外使用 / 已逾有效時限）——請評估 UPA（≤120h） / 含銅子宮內避孕器（≤5 日）
- ☐ 對 LNG 成分過敏
- ☐ 嚴重肝功能障礙（肝硬化 / 肝衰竭 / 黃疸 / 腹水）
- ☐ ⚠️ 疑似急性子宮外孕現症（單側下腹劇痛 + 面色蒼白 + 冒冷汗）→ 逕送急診

● 已先給藥、建議醫療轉介評估

- ☐ 性傳染病（STI）風險——建議篩檢
- ☐ 短期反覆使用 / 重複購買——建議常規避孕（含長效可逆避孕 LARC）諮詢、納入追蹤
- ☐ 血栓病史 / 子宮外孕病史 / 骨盆腔發炎（PID）——已強化子宮外孕警訊衛教，如有疑慮請評估
- ☐ 體重過重（>70kg / BMI>26）——已告知效果可能下降
- ☐ 其他（請說明）：_____

D. 藥師端已評估資訊（已詢問項目隨單附上、供醫師免重複問診）

項目	內容
末次月經（LMP）	_____；月經週期 ☐ 規則 ☐ 不規則
本次出血 / 月經特徵	☐ 與平常無異 ☐ 異常（量 / 天數 / 顏色）：_____
最近一次未採取保護措施性行為	____月____日____時（距轉介約 ____ 小時）
慣用避孕方式	_____
懷孕徵兆 / 驗孕	徵兆： ☐ 無 ☐ 有；驗孕： ☐ 未驗 ☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 不願驗
相關病史	☐ 血栓 ☐ 子宮外孕病史 ☐ PID ☐ 肝病 ☐ 乳癌 ☐ 其他：_____
藥物過敏	_____
目前用藥（含肝酵素誘導劑 / 保健食品，如聖約翰草）	_____
身高 / 體重 / BMI（如有收集）	____ / ____ / ____

E. 藥師處置與給藥狀態

欄位	內容
本次供藥	☐ 已先給 LNG（服藥時間____：____） ☐ 未供藥（轉介）
已執行衛教	見下 E-1 已執行衛教內容（逐項勾選）
藥師建議醫師評估重點	_____
轉出藥師 / 藥局	藥師：_____ 藥局：_____ 電話：_____

E-1. 已執行衛教內容（藥師逐項勾選，隨單附上，供醫師掌握個案已知資訊）

基礎衛教清單（●● 供藥者全員必做，對應素材 A1）

- ☐ 1 盡速服用（越早效果越好）
- ☐ 2 嘔吐補服（服藥後 2—3 小時內嘔吐須補服一劑）
- ☐ 3 常見副作用（月經提前 / 延後、點狀出血、噁心、頭痛）
- ☐ 4 警訊衛教（月經延遲逾 1 週應驗孕；服藥後約 3 週驗孕或回診；下腹劇痛 / 異常出血立即就醫——子宮外孕警訊）
- ☐ 5 補救 ≠ 常規 + 常規避孕與雙重避孕銜接衛教
- ☐ 6 肝酵素誘導劑交互作用告知（適用者：抗癲癇藥、聖約翰草等——效果可能下降）

☐ 7 社福與諮詢資源 QR Code

情境加值衛教（依個案情境勾選，對應素材 A3-1~A3-6）

- ☐ **A3-1 疑似性暴力 / 性侵害衛教：**☐ 113 通報與一站式服務流程說明（就醫會經歷什麼、社工陪同） ☐ 保留證據提醒（勿盥洗 / 換洗衣物） ☐ 心理支持資源
- ☐ **A3-2 性傳染病風險衛教：**☐ 篩檢項目建議與空窗期說明 ☐ 保險套正確使用 ☐ 伴侶篩檢與告知建議
- ☐ **A3-3 短期重複使用衛教：**☐ 常規避孕 / LARC 選項說明 ☐ 月經紊亂預期說明 ☐ 追蹤說明
- ☐ **A3-4 哺乳衛教：**可繼續哺乳；服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳
- ☐ **A3-5 社福資源逐項說明（非通報之社會風險個案）：**☐ 113 保護專線 ☐ 未成年懷孕求助
☐ 家庭福利服務中心 ☐ 性侵害 / 性騷擾防治中心 ☐ 心理支持（1925） ☐ 生育保健 / 家庭計畫諮詢
- ☐ **A3-6 就醫指引（ 不供藥 /  醫療轉介者）：**☐ 轉介事由說明 ☐ 就醫時效急迫性（UPA $\leq 120h$ / 含銅 IUD ≤ 5 日） ☐ 就醫會經歷什麼

 不供藥者無基礎衛教，僅勾 A3-6； 不符本人親領者不開立本單（僅系統記錄替代途徑告知）。系統版由資訊系統依填答自動預勾、藥師確認後送出。

F. 醫師回覆欄（雙向回覆，請於評估後回覆轉出藥局）

欄位	內容
收件日期	_____
診斷 / 處置	_____
是否需藥師後續銜接 / 追蹤	☐ 否 ☐ 是：_____
回覆方式	☐ 電子轉介平台 ☐ 電話 ☐ 紙本回覆單
回覆醫師 / 院所 / 科別	_____

G. 雙向聯絡管道

- 轉出藥局聯絡電話：_____ 轉入院所聯絡電話：_____
- 疑義即時溝通窗口（電話諮詢）：_____

三、待第 4 場確認事項

1. 轉介事由勾選項是否即以上紅黃綠分流為準？是否增列 / 刪除項目？
2. **藥師已評估欄位 (D) **之題項是否足夠讓醫師免重複問診、又不過度蒐集？（與第 5 章評估工具、線上問卷題項連動）
3. 急性子宮外孕現症是否於單上獨立標示為「急診」路徑（與一般轉介區隔）？
4. 回覆機制 (F)：是否要求醫師回覆？回覆率如何提升（現行紙本約 6—7 成）？（電子平台細節俟第 5 場）
5. 性暴力 / 性侵個案之醫療轉介與 113 通報單如何併行、是否共用本單或另設通報單？

※ 電子化平台、健保雲端註記、紙本備援範圍等資訊系統面向，俟第 5 場（8/12，第 12、13 章）決議後定案。